PROTOCOLO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PRINCIPALES SÍNDROME INFECCIOSOS EN ADULTOS DE MANEJO AMBULATORIO

Fecha de revisión: mayo 2023

GENERALIDADES Y ACLARACIONES

INFECCIONES RESPIRATORIAS

Faringitis aguda: Virus, *Streptococcus Beta-hemolítico del grupo A [S. pyogenes],* otros

REALIZAR SIEMPRE CRITERIOS CENTOR

· Fiebre superior a 38ºC (1 punto)
· Hinchazón de las amígdalas o presencia de exudado faringoamigdalar (1 punto)
· Adenopatías cervicales anteriores (1 punto)
· Ausencia de tos (1 punto)
· Edad: 3-14 años (1 punto)
5-44 años (0 puntos)
>45 años (-1 punto)

≤ 2 puntos: no realizar test ni realizar tratamiento antibiótico
≥3 puntos: considerar uso test rápido y valorar beneficio de tratamiento antimicrobiano

Otitis media aguda: *S. pneumoniae, H. Influenzae,* virus

Infección autolimitada en el 75-90% de los casos. Actitud expectante, no antibioterapia salvo excepciones:

- síntomas graves
- afectación bilateral, perforación timpánica con otorrea, OMA recurrente, antecedentes de timpanostomía y/o portador de drenaje transtimpánicos
- comorbilidad importante
- ausencia de mejoría a las 72 horas

Sinusitis: Vírica, *S.pneumoniae,H. Influenzae, M. Catarrhalis*. Diagnóstico clínico. Antibioterapia solo si:

- Si no mejora en 7 días + secreción nasal purulenta, obstrucción nasal, dolor facial, fiebre o empeoramiento rápido o significativo.
- Síntomas graves :Tº>39º,dolor facial grave > 3 días, mal estado general , empeoramiento, edema periorbitario, dolor facial o dental grave, alteración. del estado mental, diplopia, hiperestesia infraorbitaria
- Comorbilidad: Diabetes, enfermedad hepática, insuficiencia renal

Bronquitis: *Rhinovirus, Enterovirus, Influenza* (95%),*M. pneumoniae, C.pneumoniae*(5%)

No indicado tratamiento antibiótico, solo sintomático. Excepción: 7 días de evolución con elevada sospecha de etiología bacteriana

-signos de infección grave
-empeoramiento progresivo del estado general
-alto riesgo de complicaciones: DMID, IC, hospitalización año previo, uso corticoides orales >1 mes
- > 65 años > 2 criterios
- > 80 años> 1 criterio

-comorbilidad grave

EPOC: 50% bacteriana*(H.Influenzae, S.pneumoniae, M.Catarrhalis, C.pneumoniae, M.pneumoniae* (menos frecuentes), 25-30% víricas, 10-20% mixtas

Criterios de Anthonisen: Aumento de la disnea, incremento en la cantidad de expectoración, aumento de la purulencia del esputo. Antibioterapia:

- Reagudización EPOC leve(FEV1>80%) o moderada sin comorbilidad(FEV1> 50-79): 3 criterios
- Reagudización EPOC moderada con comorbilidad(FEV1 50-79%) y grave (30-49%): 2 criterios
- Reagudización muy grave(FEV1 < 30%) sospecha de *Pseudomonas aeruginosa*: cualquier síntoma

Neumonía: Varían según edad y comorbilidades, más frecuentes:*S. pneumoniae, M.pneumoniae, C. pneumoniae, H.Influenzae*

Utilización escalas pronosticas, PSI (pneumonia severity index), Curb 65

INFECCIONES de TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Las ITS de mayor prevalencia: **uretritis, cervicitis, proctitis, orquiepididimitis** de origen sexual, **enfermedad inflamatoria pélvica** comparten etiología por *N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum* aunque pueden existir múltiples microorganismos implicados: *Trichomonas vaginalis, VHS, adenovirus, enterobacterias*, etc.

En urgencias el diagnóstico de uretritis/cervicitis es clínico al objetivar exudado mucoide o purulento, aunque el gold stantard implica la realización de tinción de Gram para valorar existencia de cocos gram positivos o >2-5 leucocitos/campo.

Herpes genital es producido por *virus herpes simple (VHS) tipos 1 y 2* se caracteriza por lesiones vesiculares de 2-4mm con eritema subyacente que progresan a pústulas, erosiones y úlceras; aunque cursa con otras presentaciones atípicas. Se recomienda tratamiento si <5 días desde inicio de síntomas o existen aparición de nuevas lesiones vesiculares.

Sífilis es producida por *Treponema pallidum*. Clínica inicial de chancro primario en zona de inoculación genital/anal/oral, afectación secundaria por diseminación hematógena con exantema con afectación palmoplantar y formas terciarias con afectación cutánea (goma), ósea, cardiovascular o neurológica

(tabes) tras años de evolución. La neurosífilis puede producirse en cualquier estadio de infección e incluye la retinitis sifilítica. Latente precoz implica <1 año de evolución desde infección y latente tardía >1 año de evolución desde infección. El diagnóstico se basa en pruebas treponémicas (cualitativas) FTA y TPHA; y pruebas no treponémicas (cuantitativas) RPR y VDRL [neurosífilis]. La curación supone la reducción de 4 veces los títulos y/o negativización.

Vulvovaginitis pueden presentar diferentes etiologías:

- Vaginosis bacteriana por *Gardenella vaginalis*.
  Diagnóstico por criterios de Amsel (flujo vaginal grisáceo, pH <7,5, KOH positivo, células clue)
- Tricomoniasis por *Trichomonas vaginalis*
  Diagnóstico clínico por cérvix "fresa" y microbiológico por PCR o tinción en fresco.
- Vaginitis candidiásica por *C. albicans* (80-92%)

Diagnóstico clínico por exudado blanquecino y microbiológico por cultivo o KOH
Resistencia a azoles de *C. krusei* o *C. glabrata*.

Pediculosis púbica (ladillas) producida por *Pthirius pubis*. Diagnóstico directo por visualización de parásito, liendre o huevos.

Resumen de torundas para toma de muestras microbiológicas:

- "Medio líquido" --> PCR de exudado uretral, anal, faríngeo, úlcera genital, piel
- "Azul con medio sólido" --> Cultivo de úlcera genital, exudado uretral/anal/faríngeo
- "Roja sin medio" --> PCR (2ª opción) si no "medio líquido" disponible.

Las ITS son una oportunidad para el diagnóstico de **infección oculta de VIH**, aprovecha la valoración para solicitar una serología no urgente de VIH a todo paciente atendido por ITS en urgencias.

Considera **MPOX** dentro del diagnóstico diferencial de ITS especialmente si presenta lesiones genitales umbilicadas.

INFECCIÓN DE TRACTO URINARIO

Conceptos generales:

-Antes de iniciar antibióticos empíricos es necesario revisar las sensibilidades a los patógenos más frecuentes en nuestro hospital. Consultar en intranet FJD el estudio de sensibilidad de los patógenos que el servicio de Microbiología de Hospital Fundación Jiménez Díaz actualiza cada año.

-La tasa de resistencias de un antibiótico para usarlo como tratamiento empírico debe ser: < 20%: cistitis y < 10%: pielonefritis.

-De forma general en nuestra área no se recomienda usar empírico en infección urinaria: quinolonas, cotrimoxazol o amoxicilina-clavulánico por resistencias.

PATÓGENOS MÁS FRECUENTES EN INFECCIÓN URINARIA EN PACIENTES NO HOSPITALIZADOS Y URGENCIAS
Muestras de cultivo de orina.
Porcentaje de sensibilidades **2022** (% de cepas sensibles)

Datos recogidos por servicio de Microbiología Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
(*Nota: esta tabla ha sido editada para protocolo PROA de manejo ambulatorio de infección urinaria. La versión original está disponible en intranet FJD)

Microorganismo	Muestra	PENI	OXA	AMPI	AMC	CEFURO	CEFOTA	QUINOL	FOSFO	NITROF	COTRI	GENTA
E. coli	Orina			48.3	76.5	87.1	91.8	77.7	96.1	99.2	76.2	
K. pneumoniae	Orina			0	81.8	83.1	86.0	84.3	71.7	*	87.5	
P. mirabilis	Orina			65.3	89.9	95.1	95.7	68.7	68.3	0.1	73.1	
S. saprophyticus	Orina		90					100		-	100	
E. faecalis	Orina	-		98.8				84.1	-	-		

E. coli: 8,5 % BLEE; K. pneumoniae: 13,3 % BLEE.
-: No testado
*: Deben considerarse resistentes todas las cepas de infección urinaria

Interpretación de sedimento urinario:

- La presencia de piuria, nitritos o cambios de coloración en orina no es indicación de tratamiento de antibiótico en pacientes asintomáticos.
- Es fundamental preguntar por clínica. Si no es posible porque la situación del paciente no lo permite: intentar buscar otras causas que justifiquen el decaimiento o mayor somnolencia antes de asumir infección urinaria únicamente por un sedimento urinario "patológico".
- ¡Importante!: En los pacientes con infección del tracto urinario en los que se decida iniciar cefalosporinas empíricamente, es necesario derivar a su Médico de Atención Primaria en 48h para revisar urocultivo y disminuir espectro si se dispone de antibiograma (evitar riesgo de BLEE)
- En pacientes con infección urinaria que se plantee manejo ambulatorio si alergia a betalactámicos hay que considerar:
  - Toda alergia debe de ser estudiada y confirmada: Considerar valoración en horario de mañana por Alergología y confirmarlo.
  - Si no es posible, podría plantearse:
    - IV: amikacina 15-20mg/kg en urgencias + ciprofloxacino 500mg/12h o cotrimoxazol 800/160mg cada 12h durante 7 días pero siempre verificar sensibilidad en urocultivo en 24-48h (por riesgo de residencias como se indica en apartado superior)

Bacteriuria asintomática:

- Únicamente recibirán antibiótico si se trata de pacientes: gestante, procedimiento urológico; trasplantados renales en el 1º mes; neutropenia de alto riesgo < 100 neutrófilos.
- En pacientes con dispositivo urológico la prevalencia de bacteriuria es muy elevada sin que implique infección urinaria si está asintomático/a

Cistitis no complicada (*E. coli* (70-80%), *K.pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis)*

- Debe cumplir los siguientes criterios: mujer joven, no embarazada, sin anomalías en la vía urinaria y sin comorbilidad predisponente. (Nota: Mujeres postmenopáusicas sin comorbilidades relevantes ni factores de riesgo para mala evolución podrían incluirse en este grupo)
- No se precisa extracción de urocultivo de rutina ni antes ni después del antibiótico (salvo mala evolución)
- Elección es fosfomicina en dosis única: alcanza altas concentraciones en la orina hasta 36 horas; si 1º dosis no es eficaz, revisar que no se trate de cistitis complicada; si buena evolución, pero persiste con síntomas leves 2º dosis a las 48h
- Pensar en *Staphylococcus saprophyticus* en mujeres jóvenes sexualmente activas. Es resistente a fosfomicina y a cefixima

Cistitis complicada: *E. coli* (40%), otras enterobacterias*: Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacter, Morganella,* aumenta riesgo de BLEE *o P.aeruginosa*

Se considera en casos de:

Alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria
Portador dispositivos urinarios *(*ver apartado correspondiente)*
Intervención reciente del tracto urinario
Obstrucción de la via urinaria: litiasis, HBP, estenosis uretral, tumor urológico

Comorbilidades: diabetes mellitus con mal control, enfermedad renal crónica, inmunodeprimidos
Persistencia de síntomas tras 5-7 días de tratamiento
Grupos de riesgo: varones*, ancianos, embarazadas, niños

- En estos casos, se precisa extracción de urocultivo <u>previo</u> al inicio de antibiótico. Mayor riesgo de multirresistencias.
- Duración de antibiótico: es suficiente con 7 días, si buena evolución.
- No se recomienda realizar urocultivo de control tras finalizar tratamiento si paciente ha quedado asintomático (excepto embarazadas)
- *Nota: En varones jóvenes sin comorbilidades en los que se haya descartado ITS y prostatitis podría considerarse tratar como una cistitis no complicada.

Pielonefritis no complicada (sin criterios de ingreso): mismos microrganismos que en cistitis

- Extracción de urocultivo en todos los casos por alta rentabilidad.
- Considerar realización de Rx abdomen para descartar litiasis renal ya que clínica puede asemejarse a la de un cólico renal. En caso de confirmarse cólico complicado, considerar prueba de imagen y contactar con Urología de guardia.
- Considerar prueba de imagen si: litiasis renal, fracaso renal, monorreno o con anomalías de vía urinaria, ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico en 48-72 h (posibilidad de absceso renal).
- Si se decide manejo ambulatorio: tras primera dosis de antibiótico mantener en observación al menos 12 horas ya que 1/3 evolucionan a sepsis.
- Duración de antibiótico: 7 días si la evolución es favorable.
- Independientemente de antibiograma: no buena opción ni fosfomicina ni nitrofurantoina por no adecuado alcance a nivel renal.
- Si riesgo mala evolución, anomalías urinarias o dispositivos vía urinaria, riesgo multirresistencia: ingreso hospitalario hasta resultados microbiológicos.

Prostatitis aguda no complicada: Mismos microorganismos que cistitis, en varones jóvenes considerar ITS. Factores de riesgo para desarrollo de prostatitis: HBP; Orquitis, epididimitis o uretritis; manipulación urológica reciente.

- Descartar prostatitis en varones que refieran clínica miccional. Es una entidad frecuentemente infradiagnosticada.
- Tacto rectal (no masaje) como parte de exploración: próstata flemonosa/edematosa y dolorosa a la palpación.
- Recogida de urocultivo + extracción de hemocultivos antes de iniciar antibiótico (es complejo conseguir aislar microorganismo).
- Si paciente refiere vaciamiento vesical incompleto considerar sondaje vesical hasta resolución del cuadro.
- Si no mejora en 72h desde inicio de antibiótico se recomienda realizar prueba imagen para descartar absceso prostático.
- Es fundamental revisar urocultivo/hemocultivos al alta ya que en caso de confirmarse sensibilidad en antibiograma se recomienda modificar por su mejor penetrancia prostática a quinolonas (ciprofloxacino 500mg c/12h o levofloxacino 500mg/día) o cotrimoxazol 800/160mg cada 12h
- Duración prostatitis no complicada: 2 semanas. Prolongar 3-4 semanas si síntomas persistentes o abscesos prostáticos.
- Se recomienda derivar al alta a consulta de Urología.

Infección urinaria en portadores de dispositivos urológicos (sonda vesical, catéter ureteral, nefrostomía): Mayor riesgo de infección por microorganismos multirresistentes: *BLEE, P. aeruginosa*, *Enterococcus faecalis*, *Candida*

- Es fundamental preguntar por <u>clínica miccional</u> para evitar tratar bacteriurias asintomáticas o tratar colonizaciones (altamente frecuente en este grupo de pacientes).
- Un urocultivo positivo en portador de sonda vesical permanente, si no asocia clínica, no precisa antibiótico. En estos casos valorar recambio de sonda vesical y ver evolución.
- Si se decide que la clínica es compatible con infección urinaria nunca se deber recoger ni sedimento ni urocultivo directamente de una bolsa colectora de orina ya que el resultado no es interpretable. Si se sospecha infección: recambiar, si es posible, previamente sonda vesical antes de recoger sedimento/urocultivo. Se recomienda registrar en la historia clínica el recambio de sonda para evitar confusiones a la hora de interpretar los resultados de sedimento/urocultivo.
- Si la orina procede de nefrostomía, CMJ o urostomía, la petición de cultivo debe ser "orina nefrostomía" ya que frecuentemente es polimicrobiana.
- Antes de iniciar tratamiento se recomienda revisar si se dispone de urocultivos previos (alto riesgo de multirresistencias).
- Al alta debe solicitarse valoración por su Médico de Atención Primaria en 48h para revisión de antibiograma e intentar modificar a antibiótico de menor espectro para evitar desarrollo de multirresistencias.

Infección urinaria por enterobacterias productoras de BLEE.

Factores de riesgo:

Exposición a quinolonas y a cefalosporinas de 2-3º generación, Hospitalización previa Infecciones urinarias recurrentes	Portador de dispositivos urológicos (sonda vesical, nefrostomía) Contacto estrecho con portador o colonización previa

- Insistimos de nuevo en la importancia de tratar en pacientes con clínica. Muy frecuente tratar únicamente por resultado de urocultivo o pacientes colonizados por enterobacterias productoras de BLEE
- No está indicado el uso sistemático de carbapenemas si existen otras alternativas disponibles.
- Revisar antibiograma porque antibióticos como fosfomicina, nitrofurantoína, cotrimoxazol, ciprofloxacino o amoxicilina/ clavulánico, son alternativas válidas de tratamiento si la cepa es sensible.
- Duración del tratamiento según cuadro clínico que presente

INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS

Diagnóstico microbiológico: El diagnóstico de la mayoría de las infecciones es fundamentalmente clínico, por lo que la toma de muestra cutánea NO suele estar indicada de forma rutinaria. Reservar para infecciones complicadas: sospecha de gérmenes multirresistentes, inmunodeprimidos, infecciones de repetición, fracaso terapéutico a los tratamientos, celulitis sobre linfedema crónico (elevada rentabilidad del hemocultivo) o heridas con exposición inusual (p.e. agua dulce o salada).

Las torundas (hisopos) son de escasa rentabilidad microbiológica por lo que se deben evitar (salvo circunstancias excepcionales y siempre tomando tras frotar desde la zona más profunda). Remitir muestra con jeringa (pus o si muestra insuficiente instilar suero) o biopsia.

Mapa microbiológico ambulatorio 2022

Microorganismo	PENI	OXA	AMPI	AMC	ERITRO	CLINDA	CEFOTA	QUINOL	COTRI	GENTA	MUP	FUSID
S. pyogenes	100,0		100,0	100,0	72.2	77,8	100,0	100,0	100,0			
S. aureus	11,3	63,6	11,3	63,6	61,9	77,8		70,8	98,9	90,2	90,8	82,3

Impétigo: *S. aureus y S. pyogenes.* Evitar autoinoculación o contagio por contacto a otras personas

Foliculitis: *S. aureus y S. pyogenes*

Erisipela: *S. pyogenes.* Menos frecuente: *Estreptococo grupo B, C y G, S. aureus.* Rara vez clínica sistémica. Factores predisponentes. Frecuentes recurrencias. No se recomienda toma de muestra de hemocultivos de rutina.

Celulitis: *S. aureus, S. pyogenes,* gram negativos (inmunodeprimidos y hepatopatía crónica). Valorar puerta de entrada en la piel. Descartar riesgo de complicación y criterios de hospitalización. Valorar factores de riesgo para *S. aureus* MR (colonización previa, hospitalización prolongada o cirugía reciente, inmunodeficiencia, antibioterapia en 3 meses previos, traumatismo penetrante o venopunción, practicantes de deportes de contacto). Toma de hemocultivos si factores de riesgo de complicación o ingreso hospitalario. Plantear diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas.

Mordedura: Generalmente polimicrobianas. Considerar particularidad humana (*Eikenellacorrodens; Fusobacterium, Prevotella,* Estreptococos); perro (*Pasteurellamultocida, Capnocytophagacanimorsus*); gato (*Pasturellaspp y Pasteurellamultocida*); rata (*Spirillumminor, Streptobacillis moniliformes*).

Herida traumática (no se incluye postquirúrgica) sin criterios de gravedad: Puede ser polimicrobiana. Si cuerpo extraño (p.e. piercing), proceder a su retirada.

Herida (según antecedente epidemiológico): manipuladores carne y pescado (*Erysipelothrixrhusiopathie*); inoculación con tierra o espinas contaminadas (*Sporithrixschenckii*); herida punzante talón pie (*Pseudomonas aeruginosa*); agua y medio acuático (*Vibrio vulnificus* en agua salada, micobacterias en agua dulce, *Aeromomas*, *Pseudomonas aeruginosa*). Realizar cultivo de aspirado de herida (muestra en jeringa)

Absceso cutáneo: *S. aureus y S.pyogenes.* En ocasiones polimicrobiana.

INFECCIONES GASTROINTESTINALES

Indicación coprocultivo: Paciente inmunocomprometido o con comorbilidad, paciente con diarrea de patrón inflamatorio, paciente con criterios de gravedad, diagnóstico diferencial con sospecha de otro diagnóstico (EII), manipuladores de alimentos; caso de brote epidémico.

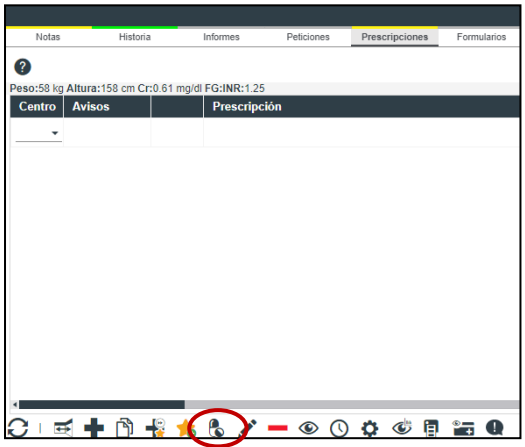
Indicación parásitos en heces (muestra en tres días consecutivos): diarrea persistente, incluido la del viajero; HSH y pacientes con VIH (mal control); diarrea con sangre, fiebre y sin leucocitos (*Entamoeba*)

Diarrea no inflamatoria: *Rotavirus, Virus Norwalk, Adenovirus, E. coli enterotógenico*, toxinas (*V. cholerae*, *S. aureus, Baciluscereus*) *Cryptosporidium y Giardia.*El 75% de los casos son de etiología vírica, autolimitados y no hay necesidad de documentar el patógeno. Los casos de etiología bacteriana suelen autolimitarse en su mayoría y el tratamiento antibiótico no ha demostrado acortar la duración del proceso.

Diarrea inflamatoria: *Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli enterohemorrágico, enterotoxigénico, E. histolytica* y *Yersinia.* Excepcional en nuestro medio: *Vibrio spp.* El tratamiento antibiótico empírico **SI** está indicado en: sospecha de etiología bacteriana y/o riesgo de infección grave en pacientes con inmunosupresión; enfermedad sistémica grave; malnutrición; drepanocitosis; pacientes con fiebre y afectación del estado general.

Diarrea del viajero: Se define como la presencia de 3 o más deposiciones de consistencia blanda-liquida en 24 h, además de presentar al menos uno de los siguientes síntomas: dolor abdominal tipo cólico, tenesmo, náuseas, vómitos, fiebre o urgencia en la deposición. El 60% de los viajeros inician la diarrea en la primera semana de viaje y la duración suele ser de 3-4 días.

Diarrea asociada *Clostridioides difícile*. Principal factor de riesgo: uso previo de antibióticos. Diagnóstico clínico con confirmación microbiológica (técnica inmuncromatografia y si discordancia, PCR *C.difficile*). Principal complicación: recurrencia. Curación por desaparición clínica NO por negativización toxina. Prescripción de vancomicina oral (capsulas) o fidaxomicina (si cumple criteriosl en Programas Farmacológicos Externos (Casiopea). Dispensación en Farmacia Hospitalaria FJD:



PROGRAMAS FARMACOLÓGICOS

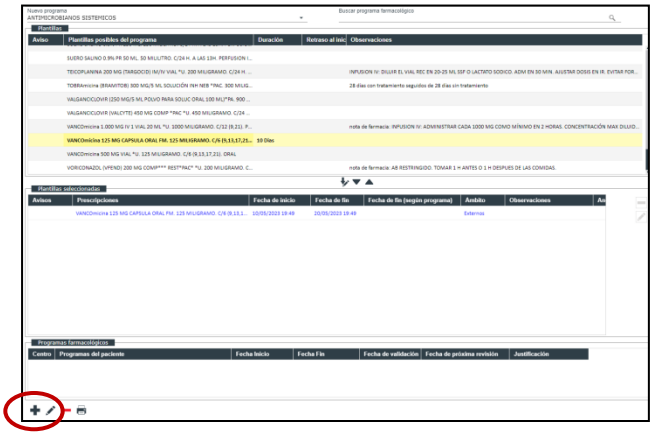


TABLA RESUMÉN TRATAMIENTO

INFECCIÓNES RESPIRATORIAS

ENTIDAD CLÍNICA	ANTIBIÓTICO PRIMERA ELECCIÓN	OBSERVACIONES Y ALTERNATIVAS
Faringitis aguda	Fenoximetilpenicilina (Penilevel) 500mg/12h, 10 días	Alternativa: Amoxicilina 500mg/8h, 5-7 d. Alérgicos a betalactámicos: Clindamicina 300mg c/8h, 5 d. Recurrencias o fallo de tratamiento: Amoxicilina/ác. clavulánico 500/125mg c/8h, 7 días
Otitis media aguda	Amoxicilina 500 mg/8h, 5 días	Si fracaso 48/72 h: amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8h, 7 días Alergia a betalactámicos (toda alergia debe de ser confirmada) Azitromicina 500 mg c/24 h, 3 días
Sinusitis aguda	Amoxicilina 500mg/8h, 5 días	SÍNTOMAS GRAVES O COMORBILIDADES O NO MEJORÍA EN 48-72H: Amoxicilina/clavulánico 875/125mg/8h, 5 días Alergia a betalactámicos (toda alergia debe de ser confirmada): Azitromicina 500 mg/24h, 3 días Si fracaso terapéutico y alérgico a los betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/24h, 5 días.
Bronquitis (causa bacteriana)	Amoxicilina 500 mg/8 h, 5 días	Si sospecha de *B. pertussis:* Azitromicina 500 mg/día, 3 días Si alergia a penicilinas: Azitromicina 500 mg/día o Levofloxacino 500 mg/24h, 5 días
EPOC	Leve (FEV1>80%) o moderada sin comorbilidad Amoxicilina/clavulánico 500/125mg c/8h, 5 días	Azitromicina 500 mg/24 h, 3 días Cefuroxima 500 mg/12 h, 5 días
	Moderada (FEV1 50-79%) con comorbilidad y grave (30-49%) Amoxicilina/clavulánico 500/125mg /8h ,5-7 días	Cefditoreno 200/12 horas 5-7 días Levofloxacino 500 mg/24 horas 5-7 días
	Reagudización muy grave (FEV1 < 30%) sospecha de *Pseudomonas aeruginosa:* Ciprofloxacino 750 mg/12h, 7-10 días	Alternativa: Cefditoreno 200 mg/12 h, 7-10 días
Neumonía adquirida en la comunidad	<65 años, no comorbilidades, no EPOC ni fumado (neumonía típica): Amoxicilina 1000 mg/8h, 5 días (reevaluación por MAP en 48 horas) *Si elevada sospecha de etiología por patógenos atípicos: Azitromicina 500 mg/día, 3 días (hasta 7 días según patógeno)	Alergia a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/24 h, 5 días Otra alternativa: Cefditoreno 400 mg/12 h, 5 días Revaluar por MAP en 48 h
	> 65 años, comorbilidades, EPOC o fumador, institucionalización en residencia de ancianos, exposición previa a múltiples ciclos de tratamiento antibiótico en año previo (≥ 3/año): Amoxicilina/Ac clavulánico 875/125 mg/8h/7 días	Levofloxacino 500 mg/24 h, 7 días Revaluar por MAP en 48 h

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Entidad clínica	Antibiótico primera elección	Observaciones y alternativas
Uretritis Cervicitis	Ceftriaxona 500mg intramuscular dosis única + Doxiciclina 100mg 1 comp/12 oral durante 7 días	Alternativa doxiciclina: Azitromicina 1g oral dosis única Alergia betalactámicos: Gentamicina 240mg intramuscular dosis única
Proctitis Proctocolitis Enteritis	Ceftriaxona 500mg intramuscular dosis única + Doxiciclina 100mg 1 comp/12 oral durante 7 días	Si sospecha linfogranuloma venero (LGV) ampliad Doxiciclina 100mg 1 comp/12h oral durante 21 días. En enteritis y colitis con sospecha de enterobacterias o parásitos: tratamiento específico con cefalosporinas, metronidazol, tinidazol, etc.
Orquiepididimitis	Ceftriaxona 500mg im + Doxiciclina 100mg/12h oral durante 10 días	Si origen no ITS: Cefixima 400mg/24h oral durante 14 días.
Prostatitis	Ceftriaxona 500mg im + Doxiciclina 100mg/12h oral durante 14 días	Si dudas origen ITS: Cefixima 400mg/24h oral + Doxiciclina 100mg/12h oral durante 14 días. Origen ITS menos frecuente que BGN en prostatitis aguda
Enfermedad inflamatoria pélvica	Ceftriaxona 2g/24h iv + Metronidazol 500mg/8h iv + Doxiciclina 100mg/12h oral durante 14 días	Única ITS que requiere prueba de imagen: ecografía abdominal o ginecológica, TC, RM para diagnóstico
Herpes genital	1er episodio: Valaciclovir 500mg/12h oral durante 7-10 días Recurrencias: Valaciclovir 500mg/12h oral durante 3 días	Otros fármacos antiherpéticos: - Aciclovir oral

	Infección grave: Aciclovir 5-10mg/kg/8h intravenoso	- Famciclovir oral Dosis según ficha técnica por tipo de episodio
Sífilis	1aria, 2aria o latente precoz: Penicilina G benzatina 2,4 Mui im dosis única 3aria, latente tardía o desconocido: Penicilina G benzatina 2,4Mui im semana/ 3 semana Nuerosífilis (incluye oftalmológico): Penicilina G sódica 4Mui/4h iv durante 14 días	Alérgicos a betalactámicos Doxiciclina 100mg/12h oral durante 14 días Alérgicos a betalactámicos Doxiciclina 100mg/12h oral durante 28 días Alternativas: Desensibilización a penicilinas o tratamiento con Ceftriaxona 1g/24h iv/im durante 14 días.
Vulvovaginitis	Vaginosis bacteriana Metronidazol 500mg/12 oral 7 días Tricomoniasis: Metronidazol 2g oral dosis única Vaginosis candidiásica: Clotrimazol 500mg óvulo dosis única	Tratamiento alternativo: Tinidazol 1g/24 oral durante 7 días Tratamiento alternativo Tinidazol 2g oral dosis única Tratamiento alternativo Fluconazol 150mg oral dosis única
Balanitis Postitis	Candidiásica Clotrimazol tópico 1 aplicación/12h durante 7-10 días Anaerobios Clindamicina/Metronidazol tópico cada 12h 7-10 días	Otras causas no infecciosas: traumática, irritativa, alérgica, neoformaciones... o infecciosas similar uretritis.
Pediculosis púbica	Permetrina 1% loción o gel (repetir a los 15 días)	Recomendación de rasurar pelo púbico

INFECCIÓN DE TRACTO URINARIO

ENTIDAD CLÍNICA	ANTIBIÓTICO EMPÍRICO ELECCIÓN	OBSERVACIONES Y ALTERNATIVAS
Cistitis no complicada	Fosfomicina trometamol 3g dosis única	-Fosfomicina: considerarlo como opción en mujeres postmenopaúsicas pero sin otros factores de riesgo para cistitis complicada -2º elección: Nitrofurantoina 100mg/12h (o 50mg/8h), 5 días
Cistitis complicada	Fosfomicina trometamol 3g con 2º dosis a las 48h	-Indicada recogida de urocultivo antes de iniciar tratamiento -2º elección: Cefixima 400mg/24h durante 7 días
Pielonefritis aguda sin criterios de ingreso	Si ausencia de datos de complicación y la situación clínica lo permite: 1) 1º dosis de ceftriaxona 2g iv en urgencias 2) Observación y si buena evolución alta con cefixima 400mg/24h hasta completar 7 días (revisando antibiograma en 48h)	-Siempre extracción de urocultivo antes de iniciar tratamiento (alta rentabilidad). -Si alérgicos: amikacina iv en urgencias + ciprofloxacino 500mg/12h al alta pero revisar urocultivo por MAP en 48h para confirmar sensibilidad y completar 7 días de tratamiento dirigido
Prostatitis aguda sin criterios de ingreso	1) Ceftriaxona 2g iv en Urgencias 2) Iniciar al alta cefixima 400mg/24h 3) Importante! Revisar siempre urocultivo y si es sensible cambiar a quinolonas o Cotrimoxazol por mejor penetrancia prostática y completar 2 semanas (desde 1º dosis de ceftriaxona en urgencias)	-Recogida de urocultivo + extracción de hemocultivos -Si vaciamiento vesical incompleto considerar sondaje vesical -Descartar posibilidad de ITS • Si alergia a betalactámicos ((toda alergia debe de ser estudiada y confirmada): amikacina 15-20mg/kg/día dosis única en Urgencias + cotrimoxazol 800/160mg cada 12h o ciprofloxacino 500mg/12h pero siempre verificar sensibilidad en urocultivo y completar 2 semanas de tratamiento dirigido
Cistitis en portador de dispositivo urológico (sonda vesical, nefrostomía, urostomía, CDJ)	Cefixima 400mg c/24h durante 7 días + recambio de sonda vesical	-Recambio de sonda vesical previo a la toma de muestra de sedimento y urocultivo - Revisar siempre urocultivos previos (alto riesgo de BLEE) • Si alergia a betalactámicos: considerar recambio sonda vesical + dosis única de amikacina IV 15-20mg/kg/24h
Infección urinaria por BLEE	Ver factores de riesgo para desarrollo de BLEE	-Revisar antibiograma para buscar opciones de antibiótico no carbapenémico: ej cotrimoxazol, amoxicilina-clavulánico, nitrofurantoina o fosfomicina. - Si cistitis sin datos de gravedad y si la función renal lo permite se puede considerar amikacina IV 15-20mg/kg dosis única y ver evolución - Si se precisa mayor duración de antibiótico por el cuadro clínico presentado y se plantea manejo ambulatorio, considerar coordinación con Continuidad Asistencial (Busca: 863773) para administración de ertapenem 1g/24h iv en Hospital de Día o en residencia (en este caso avisar a Busca Geriatría) con duración de 7 días (según cuadro clínico presentado).

INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS

ENTIDAD CLÍNICA	ANTIBIÓTICO PRIMERA ELECCIÓN	OBSERVACIONES Y ALTERNATIVAS
Impétigo	Tópico: Mupirocina 2-3 aplicaciones/24 h Duración: 5 días o hasta resolución de las lesiones Oral: solo si lesiones extensas, numerosas o que no responden al tópico (ver erisipela)	Medidas higiénicas; lavado con agua y jabón Tópico: Ácido fusídico 2-3 aplicaciones/24 h Alergia betalactámicos: Clindamicina 300 mg/8 h Toda alergia a betalactámicos debe de ser estudiada.
Foliculitis	Actitud igual que en el impétigo	
Erisipela	Cefadroxilo 500 mg/8 h, Cefalexina 500 mg/8 h, Amoxicilina 500 mg/8 h Duración: 5 días. Si evolución lenta, prolongar hasta 10 días	Medidas generales: hidratación piel, elevación extremidad, etc. Alergia betalactámicos: Clindamicina 300mg/8 h; Cotrimoxazol 800/160 mg/12 h
Celulitis	Cefadroxilo 500 mg/8 h, Cefalexina 500 mg/6-8 h Duración: 5 días, prolongar +3 días desde desaparición signos flogóticos o hasta 10-14 días si riesgo de complicación Si sospecha de SARM: Clindamicina 300mg/8h, Cotrimoxazol 800/160mg /12h, Linezolid 600mg /12h	Reevaluación a las 48-72h. Medidas de soporte y tratamiento de factores predisponentes Alergia betalactámicos: Clindamicina 300 mg/8 h Toda alergia a betalactámicos debe de ser estudiada.
Herida tras exposición carne o pescado	Amoxicilina 1000 mg/8 h, 7 días	Cultivo de aspirado de herida (indicar sospecha clínica) Alergia betalactámicos: Ciprofloxacino 500 mg/12 h
Herida por punción planta de pie	Ciprofloxacino 750 mg/12 h, 7 días	Cultivo de aspirado de herida (indicar sospecha clínica)
Herida tras exposición a agua y medio acuático	Ciprofloxacino 750 mg/12 h. Duración: mínimo 7 días, según patógeno aislado y evolución, ajustar y prolongar.	
Herida tras exposición tierra	Itraconazol 200 mg/24 h Duración: 2-4 semanas (hasta resolución de las lesiones)	Aspirado para cultivo hongo (indicando sospecha clínica)
Mordedura	Indicación profilaxis antibiótica: profunda; mordedura en, genitales, cara o próxima a articulación; extremidades en pacientes con compromiso vascular/linfático; inmunodeprimidos y diabéticos; requiera sutura Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8 h Duración profilaxis: 3-5 días	Limpieza, lavado y desbridamiento. Revisar indicación de vacunación antitetánica y antirrábica. Alergia betalactámicos: Cotrimoxazol 800/160 mg/12 h + Clindamicina 450 mg/8 h
Herida postraumática (no quirúrgica) sin criterios de gravedad	Si datos de infección, valorar amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8 h, 5 días	Realizar limpieza y desbridamiento. Revisar indicación de vacunación antitetánica. Curas periódicas.
Absceso cutáneo	Muchos casos sólo precisan incisión y drenaje sin antibioterapia. Cefalexina 500 mg/8 h (ver indicaciones) Absceso perianal/perirectal: amoxicilina/clavulánico 875/125/8 h Duración: 5 días	Indicación antibioterapia: fiebre o síntomas sistémicos; tamaño > 5 cm, celulitis asociada; múltiples localizaciones o complicadas (cara, mano, genitales); inmunodeprimidos; valvulopatía cardiaca o portador de material protésico Alergia betalactámicos: Clindamicina 300 mg/8 h, 5 días

INFECCIONES GASTROINTESTINALES

ENTIDAD CLÍNICA	ANTIBIÓTICO PRIMERA ELECCIÓN	OBSERVACIONES Y ALTERNATIVA
Diarrea no inflamatoria	No indicado tratamiento antibiótico	Tratamiento sintomático. Rehidratación
Diarrea inflamatoria	Ciprofloxacino 500 mg/12 h Azitromicina 500 mg/24 h (sospecha *Campylobacter jejuni* o embarazo) Duración: 3 días	Tratamiento sintomático. Rehidratación
Diarrea del viajero	Casos leves: tratamiento sintomático (no indicada antibioterapia) Casos moderados: Ciprofloxacino 500mg/ 12 h Si sospecha *de Campylobacter* o viajero de India/Sudeste asiático/Nepal: Azitromicina 500 mg/8 h, 3 días	Tratamiento sintomático. Rehidratación
Diarrea *C.diffcile*	Vancomicina 125 mg/6 h, capsulas oral, 10 días (dispensación hospitalaria)	Las capsulas se dispensan en Farmacia Hospitalaria previa prescripción en Programas Farmacológicos Externos (Casiopea), ver apartado Generalidades. Confirmar diagnóstico microbiológico. Suspensión de antibioterapia, IBP, anti-H2 y antiperistálticos. No recomendado uso probióticos.
Recurrencia diarrea *C.difficile*	Fidaxomicina 200 mg/12 h comprimidos oral, 10 días (dispensación hospitalaria)	